罗哌尤适硬膜外,分娩镇痛萝卜拔

（6）罗哌卡因、布比卡因　不易被代谢　作用时间已经很长　结合血浆蛋白 分子量大　作用时间长,不易透过胎盘

①血浆蛋白结合率高：作用时间长、不加肾、透过胎盘少，适合**分娩镇痛**（拔萝卜）

②**罗哌卡因**在低浓度几乎只阻滞感觉神经，更适合硬膜外镇痛（术后镇痛、分娩镇痛等）　没有阻滞运动神经,保留宫缩能力　动感分离

（7）**一次限量小结** mg：利多卡因表面麻醉 100、神经阻滞和局部浸润麻醉 400，丁卡因表面麻醉 40、神经阻滞 80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000（和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次）毒性最大

表 15-4　常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a（起效时间 弥散：解离常数越大，解离越困难）	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能　作用时间(结合分子量大,不易代谢,作用时间长)					
相对效能（穿透能力）	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*/mg	1 000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

注：* 系成人剂量，使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

局麻总结:01:01:12

四、椎管内麻醉（硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞/腰麻）

1.阻滞顺序：**交感**神经→副交感神经→感觉神经→**运动**神经→本体感觉（深感觉）（交朋友、有感觉、再运动、深入了解）

注意：阻滞的消退顺序与阻滞顺序相反，所以交感神经最先阻滞、最晚消退（作用时间最长）

2.**阻滞平面**：T_2 胸骨角、T_4 乳头（乳房四象限）、T_6 剑突（六脉神剑）、T_8 肋弓（累吧）、T_{10} 脐（10 像肚脐）、T_{12} 耻骨联合上 2-3cm/腹股沟平面

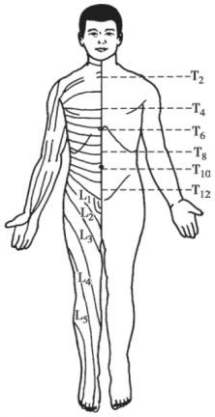


图 15-13　脊神经在体表的节段分布

